

1. Datos del Paciente

Paciente:	Mendoza Ortiz, Carlos Alberto	ID / HC:	HC-992384-A
Edad / Sexo:	28 años / Masculino	Fecha Nac.:	14/11/1997
Ingreso:	16/05/2026 - 14:15	Médico Tratante:	Dr. Alejandro Gomez (M.P. 10452)

2. Signos Vitales y Triage al Ingreso

Presión Art. (mmHg)	Frec. Cardíaca (lpm)	Frec. Resp. (rpm)	Temperatura (°C)	Saturación O ₂ (%)	Escala Dolor (EVA)
118 / 76	98	19	38.2 °C	98%	8 / 10

3. Motivo de Consulta y Enfermedad Actual

Paciente masculino de 28 años de edad, sin antecedentes mórbidos de relevancia, ingresa al servicio de urgencias refiriendo cuadro clínico de aproximadamente 14 horas de evolución. Describe dolor abdominal agudo de inicio periumbilical que posteriormente migra y se localiza en la **fosa ilíaca derecha (FID)**, de intensidad progresiva (actualmente 8/10 en la Escala Visual Análoga). El cuadro se acompaña de náuseas de origen alimentario en dos oportunidades, hiporexia marcada y registros febriles constatados en el triaje de hasta 38.2 °C.

4. Examen Físico Segmentario (Abdomen)

Abdomen: Inspección simétrica, plano, sin cicatrices previas. A la auscultación, ruidos hidroaéreos levemente disminuidos. A la palpación, se evidencia abdomen blando, depresible, francamente doloroso a la palpación superficial y profunda en fosa ilíaca derecha. Maniobras clínicas específicas positivas: **Signo de McBurney positivo, Signo de Blumberg (rebote) francamente positivo**, sugestivo de irritación peritoneal localizada. Signo de Rovsing positivo. No se palpan masas ni visceromegalias.

5. Estudios de Diagnóstico por Imagen y Laboratorio

Se solicita de manera prioritaria una **ecografía abdominal focalizada** para fosa ilíaca derecha y analítica sanguínea de urgencia.

Hallazgos Ecográficos: La ecografía abdominal muestra de forma clara una estructura tubular, aperistáltica, de fondo ciego, localizada en la fosa ilíaca derecha, compatible con el apéndice cecal, la cual se presenta francamente inflamada con un diámetro transversal máximo de **10 mm**. Se observa pérdida de la compresibilidad con el transductor, engrosamiento de la pared apendicular e incremento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular adyacente, asociado a una mínima lámina de líquido libre en la corredera parietocólica derecha.

Laboratorio (Relevante): Leucocitosis severa (14,800/mm³) con marcada desviación a la izquierda (Neutrófilos: 84%). Proteína C Reactiva (PCR) elevada en 45 mg/L.

6. Impresión Diagnóstica Final

• CIE-10: K35.8 - Apendicitis aguda, otra y la no especificada (Apendicitis aguda congestiva / supurativa con irritación peritoneal localizada).

CRITERIO DE INTERVENCIÓN URGENTE:

Debido a los hallazgos clínico-ecográficos (diámetro apendicular de 10mm, signos de rebote positivos y respuesta inflamatoria sistémica), el paciente presenta un **alto riesgo inminente de perforación apendicular y peritonitis subsecuente**. Se requiere intervención quirúrgica inmediata.

7. Conducta y Plan Terapéutico

1. **Régimen:** Nada por vía oral (NPO) estricto de forma inmediata.
2. **Hospitalización:** Ingreso inmediato al Bloque Quirúrgico Central para **Apendicectomía de Urgencia** (vía Laparoscópica preferente).
3. **Accesos Vasculares:** Vía venosa periférica permeable con hidratación parenteral activa (Solución Fisiológica 0.9% a 120 ml/h).
4. **Farmacoterapia Preoperatoria:** Profilaxis antibiótica endovenosa (Ceftriaxona 2g EV + Metronidazol 500mg EV) y manejo analgésico con Dexketoprofeno 50mg EV.
5. **Consentimiento:** Firma y validación del consentimiento informado para cirugía y anestesia general por parte del paciente.

Dr. Alejandro Gómez R.

Especialista en Cirugía General
M.P. 10452 / Reg. Urgencias 488

Dr. Matías Varas L.

Médico Residente de Turno
Servicio de Urgencias Quirúrgicas